

1. Информация об индикаторе	
Цель	Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Задача	Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах
Индикатор	Число медицинских работников на душу населения и их распределение
2. Информация об организации	
Организация	Министерство здравоохранения Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Плотность врачей: плотность врачей определяется как количество врачей, включая врачей-специалистов и медицинских работников на 10000 человек населения в стране или на уровне территориальных страновых единиц. Плотность сестринского и акушерского персонала: плотность сестринского и акушерского персонала определяется как количество сестринского и акушерского персонала на 10000 человек в стране или на уровне территориальных страновых единиц. Плотность врачей-стоматологов: Плотность врачей стоматологов определяется как количество стоматологов, зубных техников / ассистентов и ассоциированного персонала на 10000 человек населения в стране или на уровне территориальных страновых единиц. Плотность фармацевтического персонала: плотность фармацевтического персонала определяется как количество фармацевтов, помощников фармацевтов, техников / ассистентов и вспомогательного персонала на 10000 человек населения в стране или на уровне территориальных страновых единиц.
Основные понятия:	Медицинские работники - лица, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, а также выполняющие профессиональные функции по оказанию медицинской помощи, уходу, диагностике, профилактике и лечению заболеваний. Врачи (включая врачей-специалистов) - специалисты, получившие высшее медицинское образование и имеющие право заниматься врачебной деятельностью в установленном законодательством порядке. Сестринский и акушерский персонал - лица с послесредним медицинским образованием (Сестринское дело (прикладной бакалавриат), с техническим и профессиональным медицинским образованием, выполняющие функции ухода за пациентами, сестринского наблюдения, профилактики, а также оказания акушерской помощи. Врачи-стоматологи и стоматологический персонал - специалисты, предоставляющие услуги в области стоматологии, включая врачей-стоматологов, зубных техников, дантистов и вспомогательный персонал. Фармацевтический персонал - специалисты, осуществляющие

	производство, хранение, отпуск и контроль лекарственных средств, включая, фармацевтов (провизоров), фармацевтов с техническим и профессиональным фармацевтическим образованием. Плотность медицинских работников — показатель, отражающий соотношение числа работников определённой категории (врачей, среднего медперсонала, фармацевтов и др.) и численности населения, выраженный на 10 000 человек.
Обоснование и толкование	Индикатор отражает уровень обеспеченности населения Республики Казахстан медицинскими кадрами и их распределение по основным категориям медицинских работников. Используется для оценки потенциала системы здравоохранения в обеспечении доступности и качества медицинской помощи Толкование индикатора: - более высокая плотность медицинских работников свидетельствует о большей доступности медицинских услуг и потенциале системы здравоохранения к устойчивому развитию; - региональные различия в показателях указывают на неравномерность распределения кадровых ресурсов и необходимость принятия целевых мер по их выравниванию; - индикатор служит основой для кадрового планирования, определения приоритетных направлений подготовки и стимулирования медицинских работников.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	административные данные государственная статистическая отчётность: - Форма № 17 — «Отчёт о числе медицинских работников»; - Форма № 19 — «Отчёт о медицинских организациях и медицинском персонале»; - Информационная система ИС СУР (информационная система управления ресурсами); - Демографические данные - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Методы сбора данных	Сбор данных по индикатору осуществляется на основе государственной статистической отчётности и административных источников Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Данные агрегируются ежегодно по итогам отчётного периода (календарного года). Процесс сбора данных: Медицинские организации ежегодно представляют статистическую отчётность в соответствии с утверждёнными формами государственного статистического наблюдения. Территориальные филиалы ННЦРЗ проводят валидацию и консолидацию данных на региональном уровне. Центральный аппарат ННЦРЗ осуществляет свод, верификацию и последующее согласование показателей. После проверки данные направляются в Министерство здравоохранения Республики Казахстан для верификации и последующего направления в Бюро национальной статистики для включения в национальные статистические публикации и международные отчёты. Инструменты и стандарты: Используются электронные формы отчётности и

	автоматизированные информационные системы); Применяется единая система классификации согласно Классификатору занятий; Данные проходят двойную проверку достоверности - на уровне источника (медорганизации) и при агрегации в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Единица измерения	На 10 000 населения
Периодичность	Ежегодно Период наблюдения — 1 календарный год (с 1 января по 31 декабря).
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Традиционно, данный показатель оценивался с двух позиций: плотности врачей и плотности сестринского и акушерского персонала. В контексте повестки дня ЦУР показатель включает врачей, медсестер, акушеров, персонал стоматологии и фармацевтический персонал. Планируется, что данные постепенно охватят все категории медицинского персонала. Метод оценки количества врачей (включая врачей широкого профиля и врачей-специалистов) в зависимости от характера первоначального источника данных может включать практикующих врачей или всех зарегистрированных врачей. Количество сестринского и акушерского персонала включает медсестринский и акушерский персонал, когда это возможно. Во многих странах медсестер, прошедших обучение навыкам акушерства, учитывают как обычных медсестры. В связи с чем затруднено разделение на медсестринский и акушерский персонал. Количество стоматологического персонала включает стоматологов, зубных техников/ассистентов и связанных работников. Из-за изменчивости классификаций профессионального и ассоциированного уровней не всегда возможно четкое разделение по группам. Данные по количеству фармацевтического персонала включают фармацевтов, фармацевтических техников/ассистентов и связанных работников. Из-за изменчивости классификаций профессионального и ассоциированного уровней не всегда возможно четкое разделение по группам.
Комментарии и ограничения:	Данные о количестве медицинских работников наиболее полно отражены в государственном секторе, и могут недооценивать активную рабочую силу в частных, военных, неправительственных организациях и организациях, основанных на вере. Поскольку данные собираются на ежегодной основе не всеми странами, освещены последние доступные данные. Из-за различий в источниках данных охват, периодичность, качество и полнота исходных данных значительно различаются от страны к стране.
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по месту проживания (городское/сельское), географические регионы

7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	После утверждения Глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов здравоохранения: рабочая сила 2030 (WHA 69.19) для решения задач в области кадровых ресурсов для здравоохранения (КРЗ) на 69-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, май 2016 года, перед государствами-членами была поставлена задача консолидировать ключевой набор данных кадровых ресурсов здравоохранения с ежегодной отчетностью для Глобальной обсерватории здравоохранения, а также постепенно внедрить национальные счета кадров здравоохранения, в поддержку национальной политики и планирования в рамках Глобальной стратегии в области мониторинга и отчетности.
8. Ссылки и документация	